

Alle um einen autistischen Teenager / eine autistische Teenagerin

Der kumulative Leitfaden für das ganze Team um einen autistischen Teenager (12–18 Jahre) — Eltern & Familie, Lehrkräfte, Übungsleiter:innen, Ärzt:innen & Psych Personal, Betreuungskräfte, Arbeitgebende (Nebenjob) und Peers. *Ein erweitertes Nachschlagewerk; kombinieren Sie es mit den Einzel-Gegenstücks-Kurzanleitungen.*

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Teenagers in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Die Adoleszenz häuft vielspurige Anforderungen — wechselnde Peer-Regeln, Daten, Körperveränderungen, Prüfungen — auf ein System, das schnelles Wechseln als kostenintensiv empfindet. Dies ist das **Spitzenalter für Angst, Depression und Burnout**, und viele autistische Teenager (besonders Mädchen und marginalisierte Geschlechter) werden **erst in der Krise erkannt**. Welche Rolle Sie auch haben, das Nützlichste ist dasselbe: schützen Sie ihre Interessen, machen Sie das Leben vorhersagbar, senken Sie die Last, kommunizieren Sie wörtlich und nehmen Sie ihr Innenleben ernst. Ein konsistentes, akzeptierendes Team über Zuhause, Schule und Aktivitäten ist stark schützend.

Was in jedem Setting hilft

- **Schützen und validieren Sie das Spezialinteresse** — begrenzen Sie niemals eine gesunde Leidenschaft; es ist Identität, Regulation und Erholung und die beste Brücke zu Lernen und Verbindung.
- **Machen Sie den Tag vorhersagbar** — sichtbare Zeitpläne, Warnungen vor Wechseln, ein verlässlicher ruhiger Raum und eine benannte Person; halten Sie Ansätze über Settings konsistent.
- **Senken Sie sensorische und soziale Last** — ruhigere Räume, weniger erzwungene Gruppen-/Sozial-Forderungen, geschützte unstrukturierte Zeit.
- **Kommunizieren Sie wörtlich, eins nach dem anderen**, oft schriftlich; gewähren Sie Verarbeitungszeit und echte Wahl.
- **Reduzieren Sie Anforderungen, wenn der Tank leer ist** — Burnout antwortet auf Ruhe, Interessen und Entmasken, nicht auf „stärker drängen“.
- **Fragen Sie direkt und wörtlich** nach Stimmung, Angst, Freundschaften und Sicherheit — und glauben Sie die Antwort.

Was Sie in jedem Setting vermeiden sollten

- **Autistisches Burnout mit Depression** oder Faulheit verwechseln; den Teenager zum Masken, Blickkontakt oder „sei geselliger“ drängen.
- Überraschungswechsel, kurzfristige Forderungen oder erzwungene Gruppenarbeit ohne Vorbereitung.
- Das Interesse nur als zu entziehende Belohnung nutzen; Stimming stoppen.
- Eine maskierte, folgsame Stunde als „ihm geht's gut“ lesen oder einen Shutdown als Verweigerung.

Kurzhinweise für jede Person um den Teenager

Eltern & Familie

Zuhause ist, wo die Schul-Tagesmaske fällt; rechnen Sie mit einem Nachschul-Zusammenbruch und bauen Sie ruhige, anforderungsarme, interessen-geleitete Zeit ein. Schützen Sie Interessen, verwenden Sie deklarative Sprache und senken Sie Anforderungen an schweren Tagen. Setzen Sie sich in der Schule ein (Förderkoordination/SENCO, Bildungs-/Förderplan) und planen Sie den Übergang zu Erwachsenenendiensten früh.

Lehrkräfte & Tutor:innen

Machen Sie das Spezialinteresse zur Brücke zum Lehrplan; geben Sie Anweisungen schriftlich, eins nach dem anderen; schützen Sie unstrukturierte Zeit mit einer Mittags-AG oder einem ruhigen Raum. Widerstand beim Wechsel ist **Trägheit**, kein Trotz. Nehmen Sie ihr Innenleben ernst und kennzeichnen Sie Mobbing früh.

Übungsleiter:innen & Aktivitäten-Leitende

Vorhersagbare Struktur, klare Rollen, sensorische Freundlichkeit — Ihr Verein kann die sicherste Stunde ihrer Woche sein. Achten Sie auf Burnout; Ruhe und reduzierte Last sind Erholung. Ein:e Trainer:in, die/der „es versteht“, ist eine Lebensader.

Ärzt:innen & Psych Personal

Screenen Sie direkt auf Suizidalität. Unterscheiden Sie autistisches Burnout (Erschöpfung + Kompetenzverlust + verminderte Toleranz; braucht reduzierte Anforderungen und Entmasken) von Depression. Bieten Sie schriftliche/Online-Optionen; validieren Sie Interessen als Identität und Erholung; planen Sie den Übergang zu Erwachsenenendiensten früh.

Betreuungskräfte & Mentor:innen

Seien Sie die stetige, vorhersagbare Beziehung; schützen Sie Interessen und Ruhepausen; kommunizieren Sie wörtlich und schriftlich. Untersuchen Sie Schmerz oder Krankheit zuerst bei jeder neuen Belastung, und geben Sie Bedenken zu Stimmung und Sicherheit weiter.

Arbeitgebende (Nebenjob / Praktikum)

Seien Sie explizit über Erwartungen und ungeschriebene Regeln; bieten Sie schriftliche Anweisungen und geschützte Fokuszeit; geben Sie wörtliches, freundliches Feedback. Ein Praktikum ist viel neben der Schule — Flexibilität verhindert Burnout.

Peers & Freund:innen

Verabreden Sie sich um das Interesse; halten Sie es druckarm; seien Sie die Freundin/der Freund, bei der/dem sie entmasken können. Wenn sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, **sagen Sie es einer vertrauten erwachsenen Person** — ein:e Verbündete:r kann ein Leben retten.

Autistisches Burnout ist real, ernst und eigenständig — chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Reiztoleranz; es kann Monate dauern und ist mit Suizidgedanken verknüpft. Begleitende **Angst, Depression, ADHD (AuDHD), Schlaf- und Essschwierigkeiten** sind häufig und verdienen autismus-informierte Versorgung. Reduzieren Sie Anforderungen über *alle* Settings hinweg zugleich; suchen Sie autismus-positive Kliniker:innen, Peer-Gruppen und Mentor:innen.

Wenn der Teenager ein Mädchen oder ein marginalisiertes Geschlecht ist

Camouflaging gipfelt hier und treibt viel verpasste Diagnose und psychische Kosten. Der „ängstliche, perfektionistische, oberflächlich gesellige“ Teenager kann eine erschöpfte autistische junge Person sein. Nehmen Sie Masking-Erschöpfung und privates Zusammenbrechen über jedes Setting ernst.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teile 1 & 4), der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.3), **Monotrop aufwachsen** (Teil 3) und das **Monotropismus-Dossier**. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an den einzelnen Teenager an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019/2023); Leatherland (2019, Sekundarstufe); Wood (2019, Interessen & Inklusion); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, Burnout); Pearson & Rose (2021, Masking); Bradley et al. (2021, Camouflaging); Edgar (2024, Regression/Burnout); Michaud & Harvey (2025, körperliche Aktivität). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.